Flashcards — Théorie de gestion des symptômes

UE A1 — TD d'application • 40 cartes de révision

Lis la question, formule ta réponse à voix haute, puis confronte-la au verso. Les cartes couvrent la théorie, le cas Émilie et la comparaison des approches.

CARTE 01 — RECTO

Quel est l'objectif principal de la TGS ?

VERSO

Comprendre comment la personne vit et gère ses symptômes, en tenant compte de son contexte.

CARTE 02 — RECTO

À quel niveau de théorie appartient la TGS ?

VERSO

Théorie intermédiaire, centrée sur un phénomène infirmier précis.

CARTE 03 — RECTO

Nomme les trois dimensions de la TGS.

VERSO

Expérience du symptôme ; stratégies de gestion ; résultats / effets obtenus.

CARTE 04 — RECTO

Quelles questions structurent l'expérience du symptôme ?

VERSO

Que perçoit la personne ? Comment l'évalue-t-elle ? Comment le vit-elle / y répond-elle ?

CARTE 05 — RECTO

Quels sont les quatre piliers du métaparadigme ?

VERSO

Personne ; environnement ; santé / maladie ; soin.

CARTE 06 — RECTO

Que signifie « symptôme individuel » ?

VERSO

Deux personnes peuvent décrire un même symptôme mais en avoir une expérience différente.

CARTE 07 — RECTO

Pourquoi un score de douleur ne suffit-il pas ?

VERSO

Il ne décrit pas à lui seul les signes associés, le vécu, l'évolution, les effets sur la vie et les ressources.

CARTE 08 — RECTO

Quelle différence entre perception et évaluation ?

VERSO

La perception est ce qui est ressenti ; l'évaluation en précise caractéristiques, importance et retentissement.

CARTE 09 — RECTO

Que recouvre le vécu du symptôme ?

VERSO

Émotions, interprétations, réactions et sens attribué au symptôme.

CARTE 10 — RECTO

Pourquoi les facteurs internes et externes se recoupent-ils ?

VERSO

Personne et environnement interagissent ; l'important est de comprendre le lien clinique.

CARTE 11 — RECTO

Qu'est-ce qu'un facteur de contexte ?

VERSO

Une caractéristique qui influence l'expérience ou la gestion d'un symptôme.

CARTE 12 — RECTO

Quels facteurs personnels sont évoqués chez Émilie ?

VERSO

Histoire des crises, fatigue, stress ressenti, habitudes, perceptions et contraintes propres.

CARTE 13 — RECTO

Quels facteurs environnementaux sont évoqués chez Émilie ?

VERSO

Examens, études, bibliothèque, travail, écrans, rythme et ressources sociales.

CARTE 14 — RECTO

Quelles données caractérisent les migraines habituelles d'Émilie ?

VERSO

Crises récurrentes depuis l'adolescence, environ une à deux par mois auparavant, souvent intenses.

CARTE 15 — RECTO

Quel changement de fréquence des migraines Émilie rapporte-t-elle ?

VERSO

Elle rapporte cinq crises sur un mois, contre environ une à deux habituellement.

CARTE 16 — RECTO

Quels symptômes associés figurent dans le cas ?

VERSO

Nausées, gêne à la lumière et au bruit, fatigue, inquiétude, difficultés de concentration.

CARTE 17 — RECTO

Qu'est-ce qu'un cluster de symptômes ?

VERSO

Un ensemble de symptômes coexistants pouvant interagir et produire un retentissement commun.

CARTE 18 — RECTO

Pourquoi explorer un cluster ?

VERSO

Pour comprendre le vécu global, au-delà d'un symptôme isolé.

CARTE 19 — RECTO

Que représente la boucle d'auto-entretien d'Émilie ?

VERSO

Exigences quotidiennes et crises peuvent s'influencer, avec fatigue, retard et stress accrus.

CARTE 20 — RECTO

Quelle prudence devant une relation notée dans un carnet ?

VERSO

Une association observée n'est pas une preuve de cause unique.

CARTE 21 — RECTO

Nomme des stratégies d'auto-soins d'Émilie.

VERSO

Repos, calme/obscurité, arrêt de l'écran, hydratation, traitement de crise prescrit.

CARTE 22 — RECTO

Pourquoi Émilie demande-t-elle de l'aide ?

VERSO

Ses stratégies habituelles ne suffisent plus à limiter le retentissement.

CARTE 23 — RECTO

Autonomie avec un traitement prescrit = automédication ?

VERSO

Non. L'usage autonome respecte les modalités d'une prescription connue ; l'automédication est distincte.

CARTE 24 — RECTO

Que vérifier pour une prescription « si besoin » ?

VERSO

Le besoin réel et les conditions de prescription et d'administration prévues.

CARTE 25 — RECTO

Par quoi l'entretien infirmier doit-il commencer ?

VERSO

Écouter le récit de la personne et explorer son expérience, plutôt qu'imposer des conseils.

CARTE 26 — RECTO

Que faut-il recueillir sur une crise ?

VERSO

Début, fréquence, durée, intensité, signes associés, retentissement, contexte et stratégies.

CARTE 27 — RECTO

Quel est l'intérêt d'un carnet de suivi ?

VERSO

Documenter les épisodes et identifier des régularités à discuter pour ajuster la stratégie.

CARTE 28 — RECTO

Quel est le rôle de l'infirmière dans la TGS ?

VERSO

Écouter, explorer, relier les données, accompagner des solutions, sécuriser et réévaluer.

CARTE 29 — RECTO

Quand envisager une orientation ?

VERSO

Lorsque des signes d'alerte ou des limites du champ de compétences le nécessitent.

CARTE 30 — RECTO

Pourquoi des conseils généraux peuvent-ils échouer ?

VERSO

Ils peuvent méconnaître les contraintes réelles et diminuer l'adhésion.

CARTE 31 — RECTO

Qu'est-ce que la co-construction du projet de soins ?

VERSO

Choisir et ajuster avec la personne les objectifs et actions qu'elle accepte et peut appliquer.

CARTE 32 — RECTO

Comment définir l'adhésion à un projet de soins ?

VERSO

Accord actif autour d'une stratégie comprise, acceptée et faisable, sans obéissance imposée.

CARTE 33 — RECTO

Quels deux changements Émilie envisage-t-elle ?

VERSO

Ne plus sauter le déjeuner ; prévoir des pauses pendant de longues séances de travail.

CARTE 34 — RECTO

Quels résultats sont réalistes dans le cas chronique ?

VERSO

Diminuer éventuellement fréquence, intensité ou retentissement ; améliorer autogestion et qualité de vie.

CARTE 35 — RECTO

Pourquoi faut-il réévaluer ?

VERSO

Pour mesurer les effets, maintenir, ajuster ou modifier les stratégies.

CARTE 36 — RECTO

Quelle question pose le modèle des 14 besoins ?

VERSO

Quels besoins quotidiens et quelle autonomie sont perturbés ?

CARTE 37 — RECTO

Quelle question pose la TGS ?

VERSO

Comment les symptômes sont-ils vécus et gérés par la personne ?

CARTE 38 — RECTO

Quelle question pose le trifocal ?

VERSO

Comment organiser manifestations, risques et réactions humaines pour juger cliniquement ?

CARTE 39 — RECTO

Quels sont les trois axes du trifocal ?

VERSO

Situation de santé / symptômes ; risques potentiels ; réactions humaines réelles.

CARTE 40 — RECTO

Que faut-il maîtriser pour analyser un QCM de situation clinique ?

VERSO

Repérer les facteurs, le vécu et les stratégies, puis justifier l'analyse sans inventer de faits.